

Reflujo gastroesofágico

Bibliográfica 2019 – Hospital Perrupato – Dr. Navarro David
PRONAP 2011 Módulo 4

Definiciones

Pasaje retrógrado del contenido gástrico al esófago

Enfermedad por reflujo (ERGE) o “reflujo patológico”: síntomas y/o complicaciones secundarias al mismo.

RGE fisiológico: fenómeno que se produce principalmente después de las comidas, durante un período breve de tiempo que no causa enfermedad.

Es el clásico lactante que vomita y/o regurgita con variable intensidad, sin otros síntomas acompañantes, que crece y duerme bien, que se conoce como “vomitador o regurgitador feliz”.

Este cuadro se va a resolver espontáneamente en el transcurso de los primeros 2 años de vida. No se debe estudiar ni medicar.

Fisiopatología

El mecanismo fisiopatológico del reflujo gastroesofágico se desconoce. Las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior (EEI) no relacionada a deglución y/o peristalsis son consideradas las responsables del mismo.

Esta relajación ocurre en sujetos sanos pero en los pacientes con ERGE, su frecuencia y su duración es mayor.

Existe una tendencia a la desaparición o disminución del reflujo con el crecimiento, suele resolverse, en un 85 a 90% de los casos, entre el primero y el segundo año de la vida. Sin embargo, la ERGE puede presentarse en la edad preescolar y/o manifestarse en niños mayores y en algunos incluso persistir hasta la vida adulta.

Corresponde centrar el esfuerzo en identificar tempranamente a los niños con ERGE (enfermedad por RGE) para evitar complicaciones: como las estenosis, estricturas o el esófago de Barrett.

Clínica

Se debe recordar que la mayoría de los casos son lactantes vomitadores o regurgitadores felices o reflujo fisiológico.

Criterios clínicos Roma II y Roma III de RF

- Niño saludable de 1 a 12 meses de edad.
- Presencia de 2 o más regurgitaciones por día durante 3 o más semanas de evolución.
- Sin evidencia de náuseas, apneas, hematemesis, alteraciones posturales ni retraso de crecimiento.
- Sin evidencia de trastornos metabólicos, neurológicos o digestivos.

ERGE o reflujo patológico

La presentación clínica varía según la edad

Lactantes y niños pequeños

- Presentan regurgitaciones o vómitos recurrentes
- Irritabilidad, llanto
- Rechazo del alimento
- Mal dormir
- Hiperextensión del cuello (Síndrome de Sandifer)
- Inadecuado progreso ponderal
- Hallazgo de estrías de sangre al vomitar.

Neonatos y lactantes del primer semestre: asociado a ALTE

Mayores y adolescentes, más que vómitos, padecen:

- Epigastralgia o pirosis
- Nauseas
- Halitosis
- Eructos
- Sabor amargo en la boca
- Dolor retroesternal

Formas extra digestivas o síntomas atípicos

- Laringitis, disfonía
- Sinusitis
- Tos crónica, particularmente nocturna
- Obstrucción bronquial
- Neumonías
- Otitis
- Anemia
- Alteración en el esmalte dentario

En ellos puede no haber vómitos y por ello, a ésta presentación del RGE se la ha denominado RGE oculto o silente.

La disfagia, si bien es poco frecuente, debe ser considerada un signo de alarma.

La enfermedad por reflujo de larga evolución requiere una terapéutica agresiva para reducir el riesgo de secuelas graves como la estenosis péptica y el esófago de Barrett, que ya están descritos en edad pediátrica.

Estudios Complementarios

Monitoreo continuo del pH esofágico (pHmetría) de 24 hs

Es considerado el “gold standard” para el diagnóstico de reflujo gastroesofágico.

Cuantifica la exposición del esófago al ácido.

Se define un episodio de reflujo ácido a aquel que presenta pH menor de 4, durante un determinado tiempo, en general 15 a 30 segundos. Inconvenientes: no detecta episodios de RGE no ácidos. Por ende, particularmente en los lactantes con baja secreción ácida y una alimentación predominantemente láctea (alcalina), puede haber resultados falsos negativos. Esto también se observa en los pacientes con secreciones respiratorias, que por su pH alcalino, los episodios de RGE ácidos no son adecuadamente detectados.

Seriada esófagogastroduodenal

Se utiliza para evaluar la anatomía, la presencia de estenosis pilórica, membranas duodenales, hernia hiatal o mal rotación.

Tiene baja sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de reflujo (31% a 83% y 80% a 82%, respectivamente) comparada con la pHmetría.

Endoscopía y biopsia

Método de elección para demostrar daño de la mucosa por ERGE, pero la necesidad de anestesia y equipos de menor calibre que no están al alcance de muchos centros del país, hace que su uso sea más difundido en niños mayores y previo a una decisión quirúrgica.

Resulta esencial para determinar la presencia y severidad de la esofagitis, las estenosis benignas, el esófago de Barrett, así como excluir otros diagnósticos como la esofagitis eosinofílica, la enfermedad de Crohn o la esofagitis infecciosa.

Siempre se debe biopsiar, ya que pueden existir cambios histológicos sin una observación macroscópica evidente.

Una vez establecido el diagnóstico de esofagitis por reflujo, se debe corroborar mediante una segunda endoscopía la curación de las lesiones luego de finalizado el tratamiento.

Impedanciometría intraluminal multicanal (IIM), asociada al monitoreo continuo de pH, o a la manometría

Permite evaluar el movimiento dentro del esófago diferenciando deglución de reflujo así como la característica ácida o no ácida del material refluído, y la altura esofágica alcanzada por la columna líquida. Presenta la ventaja sobre la pHmetría convencional, de registrar los reflujos no ácidos y los débilmente ácidos, y determinar si el material refluído es sólido, líquido, gaseoso o mixto.

Laboratorio inicial

- Hemograma
- Urea
- Estado ácido base
- Cuerpos reductores en orina
- Chequear pesquisa neonatal, en busca de enfermedades metabólicas

Diagnósticos diferenciales

- Estenosis hipertrófica del píloro
- Membrana o atresia duodenal
- Mal rotación intestinal
- Alergia a la proteína de la leche de vaca
- Esofagitis eosinofílica
- Rumiación
- Síndrome de vómito cíclico
- Gastroparesia

Signos de alarma clínica no compatibles con ERGE

- Comienzo de los vómitos después del 6º mes de vida o esporádicos
- Pensar en hipertensión endocraneana
- Vómitos de tipo bilioso
- Distensión abdominal
- Importante y brusca pérdida de peso
- Fiebre
- Hepatoesplenomegalia: pensar en enfermedades metabólicas

Tratamiento

Reflujo Fisiológico

- Estos episodios no tienen ninguna repercusión en el lactante y la mayoría desaparecen antes del sexto mes de vida.
- La leche materna es el mejor alimento ya que permite un mejor vaciamiento gástrico con menor número de episodios.
- Si el niño es alimentado con fórmula puede proponerse el espesamiento de la misma con cereal de arroz o maíz o usar fórmula comercial espesada (AR).
- Disminuir el volumen de cada toma a 20 ml/ kg de peso, así se evita la distensión gástrica, factor favorecedor del RGE.
- Asegurar la correcta ganancia de peso.
- No movilizar al bebé en forma intempestiva después de comer
- Para dormir optar por la posición supina, en plano inclinado a 30 a 45 grados con algún arnés que evite se doblen sus piernas.
- Respetar la demanda alimentaria del niño sin forzarla
- Evitar el uso de ropa ajustada en la cintura
- Evitar fármacos que disminuyan el tono del EEl o incrementen la acidez gástrica.
- Fortalecer un buen vínculo madre-hijo-familia.
- Promover medidas higiénico-ambientales, evitando lugares contaminados, el hacinamiento y el humo de cigarrillo.

Enfermedad por reflujo gastroesofágico

En lactantes, modificaciones en las técnicas de alimentación y cambios en las fórmulas, como el espesamiento de las mismas, disminuyen el volumen refluído pero no modifican la exposición al ácido. Se postula en algunas ocasiones, la utilización de fórmulas hidrolizadas durante dos semanas como prueba terapéutica por la superposición de síntomas con alergia a leche de vaca.

En los adolescentes se recomienda, al igual que en los adultos, la prevención de los factores agravantes como el sobrepeso, evitar el hábito de fumar y el alcohol.

Tratamiento farmacológico

- **Antiácidos**, considerado el tratamiento más efectivo para el control de los síntomas, la curación de la esofagitis y la disminución del índice de exposición al ácido, tanto en niños como en adultos.
 - Antagonistas H_2 del receptor de histamina (bloqueantes H_2), como la ranitidina, tienen una efectividad del 70% en la resolución de la esofagitis luego de seis semanas de tratamiento.
La desventaja de estos fármacos es la presencia de taquifilaxia.
La dosis recomendada es 5-10 mg/kg/día.
 - Inhibidores de la bomba de protones (IBP), demostraron ser efectivos en la resolución de los síntomas moderados a severos de ERGE luego de 3 meses de tratamiento, tienen una mayor respuesta en la inhibición ácida con respecto a los bloqueantes H_2 .
Dosis en pediatría:
Lanzoprazol: 1-2,8 mg/ kg/ día, máximo 30 mg
Omeprazol: 0,7-3 mg /kg /día en dos tomas diarias
- **Domperidona**: aumenta el tono del esfínter esofágico inferior, por su actividad proquinética. La domperidona tiene idéntico efecto sobre el QT que el cisapride y no ha sido aprobado por la FDA, no recomendándose su uso, además de contar con insuficiente literatura científica que los avale en lactantes y niños, sin embargo en la actualidad es ampliamente usada en el tratamiento.

Cirugía

Actualmente existe una terapéutica farmacológica muy efectiva por lo cual las indicaciones de cirugía se han restringido a las siguientes situaciones:

- Inadecuada respuesta al tratamiento médico o recurrencia de los síntomas a pesar del mismo
- Presencia de reflujo no ácido con repercusión clínica por ello, ALTE severo
- Todos aquellos niños con compromiso neurológico con riesgo de aspiración

El abordaje y la técnica quirúrgica dependerán de las características del paciente y del entrenamiento del equipo, siendo la funduplicatura de Nissen, la más utilizada en nuestro medio.

Según las distintas series descriptas en la literatura se observa un alivio de los síntomas entre un 60 y 92%, siendo la complicación más frecuente la disfagia y dificultad de eructar en un 6% de los pacientes.

